CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ VINMEC

Nhóm tài liệu: ***Tài liệu đào tạo - chuyên môn***

CLINICAL PATHWAY CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ NHỒI MÁU CƠ TIM CẤP

MÃ VĂN BẢN : ***VMEC_CM127***

NGÀY PHÁT HÀNH LẦN ĐẦU : ***03/08/2021***

NGÀY PHÁT HÀNH: ***03/08/2021***

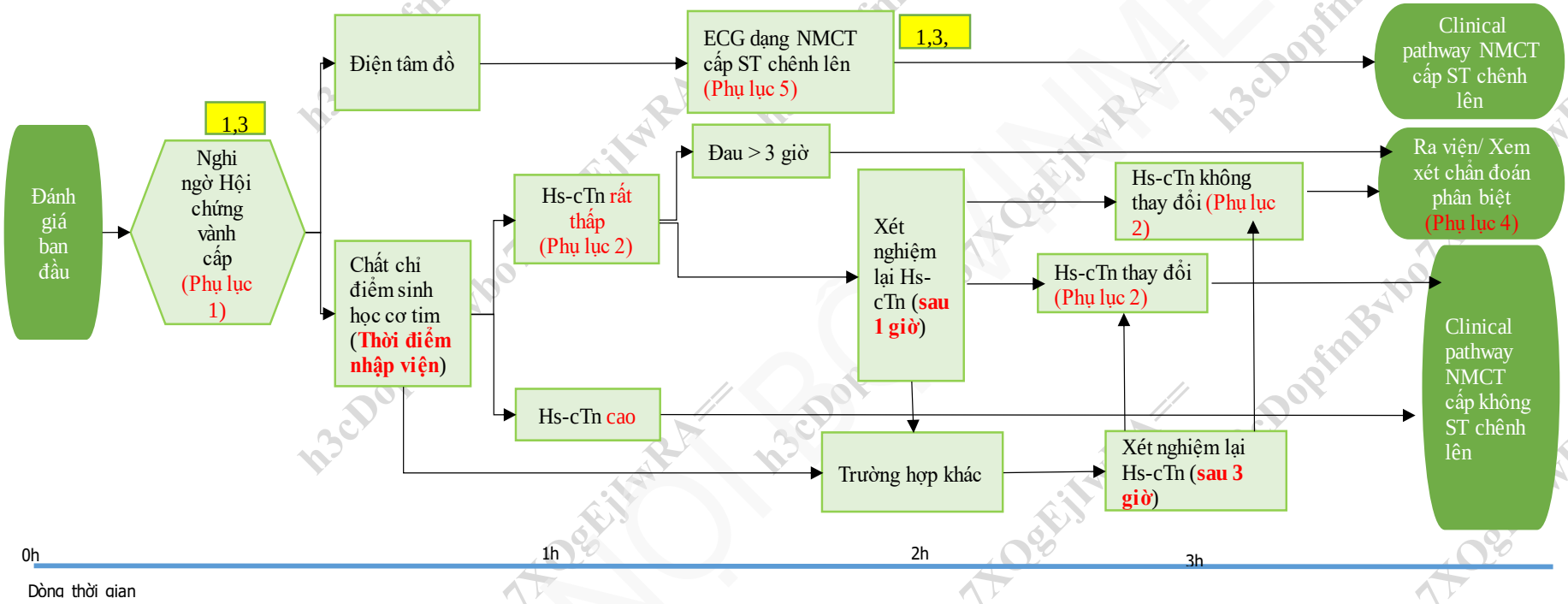
NGÀY HIỆU CHỈNH: ***08/2024***

ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG: ***Bác sỹ, Điều dưỡng chuyên ngành tim mạch***

NGÀY HIỆU CHỈNH TIẾP THEO: ***08/2027***

Tài liệu này là tài sản của Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec, mọi hình thức sao chép, phát tán trái phép sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.
This document is the property of the Vinmec International Hospital, all forms of illegal copying, distributing will be dealt with pursuant to the law of Vietnam.

PHẦN 1: ĐÁNH GIÁ VÀ CHẨN ĐOÁN

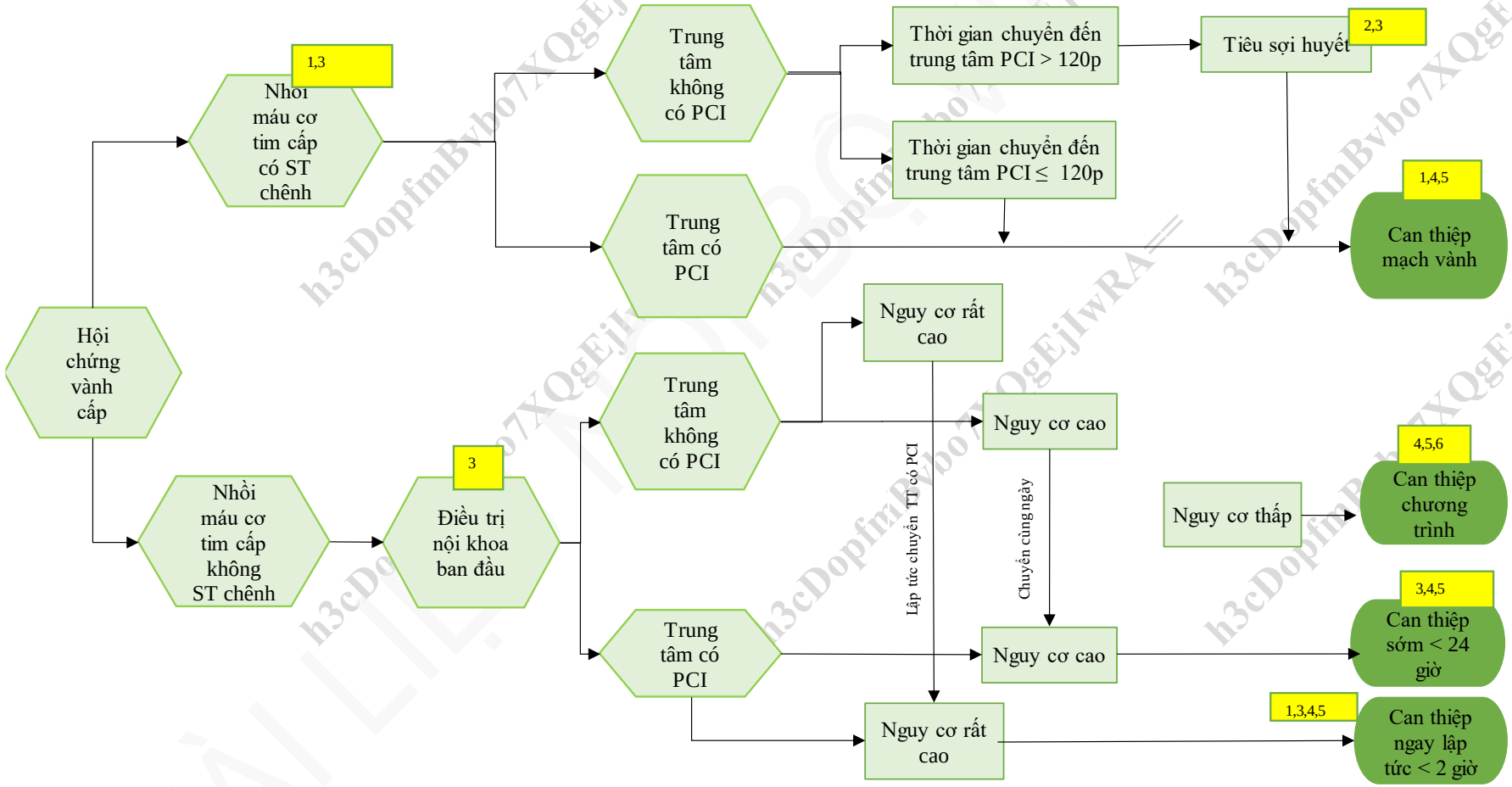


Tài liệu này là tài sản của Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec, mọi hình thức sao chép, phát tán trái phép sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.
This document is the property of the Vinmec International Hospital, all forms of illegal copying, distributing will be dealt with pursuant to the law of Vietnam.

*** Triệu chứng điển hình** : • Đau thắt (bóp) nghẹt sau xương ức, có thể lan lên vai trái, lên cằm, lên cả hai vai. • Cơn đau xuất hiện khi nghỉ, thường kéo dài trên 20 phút • Cơn đau không giảm khi ngậm nitroglycerin • Triệu chứng đi kèm gồm vã mồ hôi, nôn ói, đau thượng vị, khó thở, ngất	Các chất chỉ điểm sinh học cơ tim thường được dùng để chẩn đoán, phân tầng nguy cơ và theo dõi là Troponin T hoặc I. Tốt nhất là các xét nghiệm siêu nhạy (như TroponinT hs hoặc I hs) Hiện nay, các hướng dẫn chẩn đoán nhồi máu cơ tim sử dụng phác đồ 1 giờ hoặc 2 giờ. **Hs-cTn** : Troponin siêu nhạy Giá trị tham khảo của Hs-cTn T (máy Elecsys, Roche) Giá trị tham khảo của Hs-cTn I (Beckman Access, Abbott, Siemens Vista) **Rất thấp:** < 5 ng/L **Thấp:** < 12 ng/L **Cao:** ≥ 52 ng/mL sau 1h có thay đổi: ≥ 5 ng/mL, sau 1h không có thay đổi: < 3 ng/mL
PHỤ LỤC 3 - Đánh giá nguy cơ	**PHỤ LỤC 4 - Chẩn đoán phân biệt**
Nguy cơ rất cao: • Huyết động không ổn định • Sốc tim • Đau ngực tái phát/kháng trị với điều trị nội • Rối loạn nhịp nguy hiểm • Biến chứng cơ học của nhồi máu cơ tim • Suy tim cấp do nhồi máu cơ tim • ST chênh xuống 1mm trên 6 chuyển đạo kèm theo ST chênh lên ở V1/aVr **Nguy cơ cao:** • Xác định chẩn đoán nhồi máu cơ tim • Đoạn ST-T thay đổi động học • Điểm GRACE > 140 • Hồi sức ngưng tim nhưng không có ST chênh lên hay sốc tim **Nguy cơ thấp:** • Không có tiêu chuẩn của nguy cơ rất cao và nguy cơ cao	Viêm màng ngoài tim Bệnh cơ tim Nhịp nhanh Suy tim cấp Tăng huyết áp cấp cứu Hẹp van động mạch chủ Hội chứng Takotsubo Co thắt mạch vành Thuyên tắc phổi Viêm màng phổi, Viêm phổi Phình động mạch chủ có triệu chứng Bóc tách động mạch chủ Viêm dạ dày, viêm tụy Chấn thương ngực, chấn thương tim, tổn thương cơ Rối loạn lo âu

Tài liệu này là tài sản của Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec, mọi hình thức sao chép, phát tán trái phép sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.
This document is the property of the Vinmec International Hospital, all forms of illegal copying, distributing will be dealt with pursuant to the law of Vietnam.

PHỤ LỤC 5 - Điện tâm đồ	
ST chênh lên hằng định hoặc mới có xuất hiện bloc nhánh trái thì cần phải nghĩ đến NMCT ST chênh lên Trong cơn đau có thể thấy sự biến đổi của đoạn ST: thường gặp nhất là đoạn ST chênh xuống (nhất là kiểu dốc xuống), T âm nhọn, đảo chiều, ST có thể chênh lên thoáng qua Có tới trên 20% bệnh nhân không có thay đổi tức thời trên ĐTĐ, nên làm ĐTĐ nhiều lần.	
PHẦN 2: ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ	



Tài liệu này là tài sản của Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec, mọi hình thức sao chép, phát tán trái phép sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.
This document is the property of the Vinmec International Hospital, all forms of illegal copying, distributing will be dealt with pursuant to the law of Vietnam.

Điều trị nội khoa	Điều trị cấp cứu ban đầu
Kháng kết tập tiểu cầu kép: Kết hợp Aspirin và một loại thuốc ức chế P2Y12 (Ticagrelor, Prasugrel, Clopidogrel) **Aspirin:** Liều nạp: 150 - 300 mg. Liều duy trì: 75 - 100 mg/ngày **Ticagrelor**: Liều nạp 180 mg. Liều duy trì: 90 mg x 2/ngày (không dùng ở bệnh nhân tiền căn xuất huyết nội sọ) hoặc **Prasugrel:** Prasugrel với những BN chưa sử dụng các thuốc ức chế P2Y12 và đang chuẩn bị làm can thiệp ĐMV qua da (60 mg liều nạp, 10 mg hàng ngày hoặc 5 mg hằng ngày đối với bệnh nhân ≥ 75 tuổi hay < 60kg), không dùng ở bệnh nhân có tiền căn đột quỵ, cơn thoáng thiếu máu não hoặc **Clopidogrel:** chỉ khi không có prasugrel hoặc ticagrelor hoặc có chống chỉ định với hai loại này. Ưu tiên sử dụng Clopidogrel nếu bệnh nhân dùng chung với tiêu sợi huyết * **Đối với nhồi máu cơ tim không ST chênh**: liều nạp 300-600 mg, liều duy trì 75 mg/ngày * **Đối với nhồi máu cơ tim cấp ST chênh:** Liều nạp 600mg đối với bệnh nhân không sử dụng tiêu sợi huyết và liều nạp 300 mg (75mg ở bệnh nhân ≥ 75 tuổi) đối với bệnh nhân sử dụng tiêu sợi huyết, liều duy trì: 75 mg/ngày **Thuốc kháng đông:** Được sử dụng kết hợp với kháng tiểu cầu kép + **Enoxaparin** (Heparin trọng lượng phân tử thấp): **Liều tải** (đối với nhồi máu cơ tim cấp ST chênh lên): 0.5 mg/kg tiêm mạch (đối với bệnh nhân ≥ 75 tuổi không cần liều tải) **Liều duy trì:** 1mg/kg x 2 lần/ngày tiêm dưới da, giảm liều còn 0.75mg/kg đối với bệnh nhân ≥ 75 tuổi và sử dụng 1 lần/ngày ở bệnh nhân có suy thận với MLCT <30mL/phút. **Thời gian sử dụng:** Cho đến khi bệnh nhân được điều trị tái thông hoặc tối đa 8 ngày. **Điều trị hạ lipid máu:** Sử dụng statin liều cao (Atorvastatin 40-80 mg hoặc rosuvastatin 20-40mg được sử dụng sớm nhất có thể, mục tiêu LDL-C < 1.4 mmol/l hoặc giảm > 50% mức LDL hiện tại nếu LDL hiện tại 1.8 - 3.5 **Ức chế men chuyển/ Ức chế thụ thể:** Sử dụng sớm trong 24h giờ đầu đặc biệt ở bệnh nhân suy tim, rối loạn chức năng thất trái, đái tháo đường, nhồi máu thành trước. Thuốc ức chế thụ thể được sử dụng thay thế ức chế men chuyển khi bệnh nhân không dung nạp được. **Thuốc kháng aldosterol:** Khuyến cáo ở bệnh nhân EF ≤ 40% và suy tim hoặc đái tháo đường **Ức chế beta**: Sử dụng trong 24h đầu nếu bệnh nhân không có chống chỉ định. **PPI:** Được phối hợp với DAPT nếu bệnh nhân có nguy cơ tiêu hóa cao	• Oxy liệu pháp khi SpO2 < 90% • Nitrate ngậm dưới lưỡi hoặc ức chế beta được sử dụng để giảm triệu chứng thiếu máu cơ tim • Giảm đau bằng opioid có thể được xem xét • An thần nhẹ (benzodiazepine) có thể được sử dụng ở bệnh nhân rất lo lắng • Đối với bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp có ST chênh lên, bệnh nhân cần được theo dõi ở đơn vị hồi sức mạch vành và theo dõi ECG ít nhất 24 giờ
	Điều trị tái tưới máu
	A. Đối với nhồi máu cơ tim cấp ST chênh lên: *** Tiêu sợi huyết:** **Alteplase:** 15 mg Bolus Sau đó 0.75 mg/kg truyền tĩnh mạch trong 30 phút (tối đa 50mg) Sau đó 0.5 mg/kg truyền tĩnh mạch trong 60 phút (tối đa 35mg) **Streptokinase:** 1.5 triệu đơn vị, truyền tĩnh mạch trong 30-60 phút *** Can thiệp mạch vành:** PCI được chỉ định ở tất cả bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp ST chênh lên ≤ 12h Can thiệp mạch vành được xem xét ở bệnh nhân giai đoạn muộn (12-48 giờ). *** Phẫu thuật bắc cầu mạch vành:** Khi giải phẫu mạch vành không phù hợp để PCI hoặc bệnh nhân có biến chứng cơ học khi chưa được điều trị tái thông. **B. Đối với nhồi máu cơ tim cấp không ST chênh:** Chiến lược điều trị tái tưới máu bằng can thiệp mạch vành phụ thuộc vào phân tầng nguy cơ như sơ đồ. *** Phẫu thuật bắc cầu mạch vành:** Các tổn thương quá phức tạp (vôi hoá, xoắn vặn, gập góc, chỗ chia nhánh…) mà việc can thiệp nong hoặc đặt stent không khả thi hoặc lợi ích không tốt. Có thể dùng thang điểm SYNTAX để tính toán, ước lượng hiệu quả /nguy cơ của can thiệp hoặc phẫu thuật để quyết định (tham khảo www.syntaxscore.org)

Tài liệu này là tài sản của Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec, mọi hình thức sao chép, phát tán trái phép sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.
This document is the property of the Vinmec International Hospital, all forms of illegal copying, distributing will be dealt with pursuant to the law of Vietnam.

PHẦN 3: RA VIỆN VÀ ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ

TIÊU CHUẨN XUẤT VIỆN

Triệu chứng đau tức ngực hoặc khó thở được cải thiện
Tăng khả năng gắng sức mà không còn triệu chứng
Kiểm soát được các yếu tố nguy cơ đi kèm như :Tăng huyết áp, đái tháo đường type 2, rối loạn lipid máu.
Bệnh nhân được hướng dẫn chế độ điều trị, chăm sóc tại nhà phù hợp

HƯỚNG ĐIỀU TRỊ TIẾP THEO

Kháng kết tập tiểu cầu kép được sử dụng ít nhất 12 tháng nếu như nguy cơ xuất huyết thấp (theo thang điểm PRECISE DAPT)
Statin cường độ cao, lâu dài (suốt đời)
Điều trị giảm đau thắt ngực: nitrate; chẹn beta hoặc chẹn kênh calci tiếp theo điều trị đã sử dụng trong viện
Dùng chẹn beta giao cảm kéo dài để cải thiện tiên lượng khi bệnh nhân có EF giảm.
Dùng các thuốc ức chế hệ renin angiotensin aldosteron hoặc ức chế thụ thể AT1 theo chỉ định
Phối hợp thuốc PPI nếu bệnh nhân có bệnh lý dạ dày- tá tràng
Phòng ngừa cúm ở bệnh nhân trên 65 tuổi

GIÁO DỤC SỨC KHỎE BỆNH NHÂN

Hướng dẫn thay đổi lối sống

* Bỏ thuốc lá
* Chế độ ăn lành mạnh:
- Rau và trái cây > 200g/ngày
- 35-45g chất xơ mỗi ngày, đặc biệt là ngũ cốc
- Khẩu phần cá 1-2 lần/tuần (có dầu cá)
- Hạn chế chất béo bão hòa (<10% năng lượng), thay thế bằng chất béo không bão hòa
- Hạn chế muối < 5-6g/ngày
- Hạn chế rượu < 100g/tuần hay 15g/ngày
- Tránh thực phẩm giàu năng lượng như nước ngọt có đường

* Kiểm soát cân nặng:
Vòng eo < 94 cm đối với nam (90 với người châu Á) và < 80cm đối với nữ
BMI 18.5 - 25 kg/m2

* Hoạt động thể chất: Hoạt động thể chất 30-60p ít nhất 5 ngày/tuần và đều đặn
* Tuân thủ điều trị

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. 2017 ESC Guidelines for the management of acute myocardial infarction in patients presenting with ST-segment elevation
2. 2015 ESC guidelines for the management of acute coronary syndromes in patients presenting without persistent ST-segment elevation
3. 2020 ESC Guidelines for the management of acute coronary syndromes in patients presenting without persistent ST-segment elevation
4. Khuyến cáo về chẩn đoán và điều trị Hội chứng mạch vành cấp không ST chênh lên 2016, Hội Tim mạch học Việt Nam.

Tài liệu này là tài sản của Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec, mọi hình thức sao chép, phát tán trái phép sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.
This document is the property of the Vinmec International Hospital, all forms of illegal copying, distributing will be dealt with pursuant to the law of Vietnam.

NHỮNG QUY TRÌNH CHUYÊN MÔN LIÊN QUAN
1. Quy trình kỹ thuật chuyên môn can thiệp thì đầu trong nhồi máu cơ tim cấp st chênh lên. mã văn bản: vmec_cm113
2. Quy trình điều trị tiêu sợi huyết trong nhồi máu cơ tim cấp st chênh lên (stemi). mã văn bản: vmec_cm113
3. Hướng dẫn sử dụng thuốc kháng kết tập tiểu cầu trong hội chứng động mạch vành cấp. mã văn bản: vmec_cm11
4. QTKT chuẩn bị dụng cụ, người bệnh trước khi đưa đi can thiệp và chăm sóc người bệnh sau can thiệp tim mạch – trang 163 mã văn bản: vmec_cm113
5. Quy trình chụp động mạch vành - mã văn bản: vmec_cm113
6. QTKT nong và đặt stent mạch vành theo chương trình – trang 257 mã văn bản: vmec_cm113
7. Qquy trình phẫu thuật mạch vành - vmec_cm113

NGƯỜI SOẠN THẢO: ***Lã Thị Thùy, Võ Thành Nhân, Đỗ Doãn Lợi***

NGƯỜI THẨM ĐỊNH: ***Trưởng Tiểu ban Tim mạch***

NGƯỜI PHÊ DUYỆT: ***Phó tổng giám đốc chuyên môn***

Các từ viết tắt

- *GRACE SCORE: The Global Registry of Acute Coronary Events*
- *PCI: percutaneous coronary intervention*
- *DAPT: Dual Antiplatelet Therapy*
- *PCI: percutaneous coronary intervention*

Ghi chú:

- *Văn bản được phát hành lần đầu.*

Tài liệu này là tài sản của Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec, mọi hình thức sao chép, phát tán trái phép sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.
This document is the property of the Vinmec International Hospital, all forms of illegal copying, distributing will be dealt with pursuant to the law of Vietnam.

Phụ lục 1. Checklist chẩn đoán và điều trị nhồi máu cơ tim cấp
Họ tên BN:
Chẩn đoán (ICD):
Phương pháp kiểm tra:

PID

TT	Hạng mục kiểm tra	Nội dung kiểm tra	MS tiêu chí	Tiêu chuẩn/ Yêu cầu đạt được	Kết quả			Mô tả tình trạng không đạt	Ghi chú
					Đạt/ Có	Không đạt/ Không có	Không áp dụng		
1	Đánh giá và chẩn đoán	Đánh giá	**1.1 ***	Đánh giá lâm sàng (theo PL1)					
			1.2 *	Thực hiện điện tâm đồ					
			1.3 *	Thực hiện dấu ấn sinh học cơ tim 2 mẫu (1h và 3h)					
		Chẩn đoán và phân loại (nếu có)	**1.4 ***	Chẩn đoán bệnh, giai đoạn bệnh					
			1.5	Đánh giá nguy cơ theo thang điểm GRACE SCORE					
			1.6 *	Dựa vào phân tầng nguy cơ tim mạch đưa ra hướng điều trị phù hợp					
2	Điều trị	Xử trí nội khoa ban đầu	**2.1 ***	Kháng đông và kháng kết tập tiểu cầu kép (liều nạp và liều duy trì phù hợp)					
			2.2 *	Các thuốc khác: Statin, ức chế men chuyển, chẹn beta giao cảm (nếu không có chống chỉ định)					
		Điều trị can thiệp (bao gồm điều trị toàn diện, phối hợp đa ngành: dinh dưỡng, PHCN...)	**2.3 ***	Chỉ định điều trị xâm lấn hoặc không xâm lấn phù hợp với tình trạng bệnh (theo clinical pathway phần điều trị)					
			2.4 *	Lựa chọn chiến lược tái tưới máu phù hợp (PCI hoặc phẫu thuật CABG) (theo clinical pathway phần điều trị)					
			2.5	Hội chẩn " heart team" trước khi can thiệp hoặc phẫu thuật					
			2.6 *	Theo Quy trình kỹ thuật tim mạch đã ban hành					

Tài liệu này là tài sản của Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec, mọi hình thức sao chép, phát tán trái phép sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.
This document is the property of the Vinmec International Hospital, all forms of illegal copying, distributing will be dealt with pursuant to the law of Vietnam.

Phụ lục 1. Checklist chẩn đoán và điều trị nhồi máu cơ tim cấp
Họ tên BN:
Chẩn đoán (ICD):
Phương pháp kiểm tra:

PID

TT	Hạng mục kiểm tra	Nội dung kiểm tra	MS tiêu chí	Tiêu chuẩn/ Yêu cầu đạt được	Kết quả			Mô tả tình trạng không đạt	Ghi chú
					Đạt/ Có	Không đạt/ Không có	Không áp dụng		
		Thực hiện thủ thuật PCI hoặc phẫu thuật CABG	**2.7 ***	Đánh giá kết quả bằng: Bảng tường trình phẫu thuật/ thủ thuật					
		Theo dõi & xử trí tai biến/biến chứng sau phẫu thuật/thủ thuật	**2.8 ***	Chuyển ICU/CCU theo dõi sau phẫu thuật/ thủ thuật Theo dõi sinh hiệu và mắc monitor theo dõi liên tục (triệu chứng đau ngực, mạch, nhiệt độ, HA, SpO2, nơi đâm kim) mỗi 2h					
			2.9	Làm các xét nghiệm sau thủ thuật: chức năng thận, điện tim thường, siêu âm tim, men tim					
			2.10*	Vật lý trị liệu tim mạch phục hồi sau nhồi máu (phối hợp cùng chuyên khoa vật lý trị liệu)					
3	Theo dõi sau ra viện	Tiêu chuẩn xuất viện	3.1	Triệu chứng đau ngực, khó thở, ngất được cải thiện					
			3.2	Tăng khả năng gắng sức mà không còn triệu chứng					
		Hướng điều trị tiếp theo	**3.3 ***	Điều trị tiếp tục các thuốc theo đánh giá điều trị ngoại trú (phần 3 clinical pathway: Ra viện và điều trị ngoại trú)					
			3.4	Kiểm soát được các yếu tố nguy cơ đi kèm như: Tăng huyết áp, đái tháo đường type 2, rối loạn lipid máu.					
		Giáo dục sức khỏe bệnh nhân	3.5	Bệnh nhân được hướng dẫn chế độ điều trị, chăm sóc tại nhà phù hợp					

Tài liệu này là tài sản của Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec, mọi hình thức sao chép, phát tán trái phép sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.
This document is the property of the Vinmec International Hospital, all forms of illegal copying, distributing will be dealt with pursuant to the law of Vietnam.

Phụ lục 1. Checklist chẩn đoán và điều trị nhồi máu cơ tim cấp
Họ tên BN:
Chẩn đoán (ICD):
Phương pháp kiểm tra:

PID

TT	Hạng mục kiểm tra	Nội dung kiểm tra	MS tiêu chí	Tiêu chuẩn/ Yêu cầu đạt được	Kết quả			Mô tả tình trạng không đạt	Ghi chú
					Đạt/ Có	Không đạt/ Không có	Không áp dụng		
			3.6	Kiểm tra sức khỏe định kỳ hàng tháng					
Tổng tiêu chí					**22**				
Số tiêu chí dấu*					**14**				
Số tiêu chí thường áp dụng									
Kết quả số lượng/Xếp loại tiêu chí thường									
Kết quả số lượng/Xếp loại tiêu chí dấu *									
Xếp loại 2 tiêu chí									

Hướng dẫn:

Tiêu chuẩn: Mỗi HSBA được đánh giá là Đạt theo checklist phải đảm bảo các tiêu chuẩn sau đây:

_Những tiêu chí có đánh dấu *: là tiêu chuẩn bắt buộc phải đạt trong quá trình đánh giá (nếu **chỉ cần 1** trong những tiêu chí có dấu * không đạt thì coi như HSBA đó là không đạt)

_Đảm bảo về số lượng những tiêu chí còn lại (không có dấu sao) đạt 90%

Tài liệu này là tài sản của Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec, mọi hình thức sao chép, phát tán trái phép sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.
This document is the property of the Vinmec International Hospital, all forms of illegal copying, distributing will be dealt with pursuant to the law of Vietnam.